

Paciente	Adolescente · 14 años	Dx principal	CPTSD (CIE-11: 6B41)
Intereses	Boxeo ■ · Río ■ · Peluquería ➤■	Antec. suicidio	3 intentos previos — RIESGO MÁXIMO

■ PRIORIDAD ABSOLUTA — RIESGO VITAL ACTIVO

Riesgo de reintento:	La paciente presenta 3 intentos de suicidio previos, situándola en el grupo de máximo riesgo estadístico.
Evaluación:	Evaluación del riesgo suicida en cada contacto mediante la escala Columbia C-SSRS para adolescentes.
Plan de Seguridad (Stanley-Brown SPI):	Identificación de señales de alerta, personas de confianza, estrategias de distracción y retirada de medios letales.
Obligación Legal:	Notificación mandatoria a protección de menores por presunto delito de abuso sexual intrafamiliar.
Soporte Farmacológico:	Valoración psiquiátrica urgente, considerando ISRS y vigilancia de activación conductual.

■ DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN CLÍNICA

- **Diagnóstico Principal:** TEPT Complejo (CPTSD) según CIE-11 (6B41).
- **Comorbilidades:** Trastorno Depresivo Mayor severo · Trastorno de Ansiedad reactivo al trauma.
- **A explorar:** Posible TDI (inicio abusos a los 6 años, crisis disociativas) y TLP emergente.
- **Factores de mantenimiento:** Trauma relacional primario con el agresor como figura de apego · inicio preverbal-temprano con daño en el desarrollo del self · autolesiones como regulación disfuncional.

■ COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Psiquiatría infanto-juvenil	Seguimiento farmacológico
Psicología clínica	Intervención psicoterapéutica principal
Enfermería salud mental	Psicoeducación y plan de seguridad
Trabajo social	Coordinación protección de menores y familia extensa
Centro educativo	Protocolo de apoyo y vigilancia con escolarización activa

■ FASE 1 — ESTABILIZACIÓN (PRIORITARIA)

Duración: 3-6 meses mínimo, sesiones semanales o más frecuentes.	Modalidad: DBT-A (Terapia Dialéctica Conductual para Adolescentes).
Objetivo: Establecer seguridad y regulación del SN <i>sin</i> procesar contenido traumático.	Entorno: Inclusión de un adulto protector en el módulo familiar de DBT-A.

Técnicas de primera elección:

Tolerancia al malestar	Habilidades TIPP, ACCEPTS, IMPROVE.
Regulación emocional	Identificación de emociones, PLEASE, Opuestos a la acción.
Grounding 5-4-3-2-1	Herramienta central para crisis disociativas. Ancla al presente mediante los 5 sentidos.
Técnica STOP	Intervención en crisis agudas: Stop, Take a step back, Observe, Proceed mindfully.
Psicoeducación disociación	Trabajo suave con partes (IFS) — no procesar trauma todavía.

■ Nota Crítica: El vínculo terapéutico es el principal instrumento de reparación ante el daño profundo en la confianza.

■ FASE 2 — PROCESAMIENTO TRAUMÁTICO

Inicio: Solo tras alcanzar estabilidad mínima sostenida.	Duración: 6-18 meses adicionales.
---	--

Opciones terapéuticas:

TF-CBT	Terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Primera línea para abuso sexual en adolescentes.
EMDR adaptado	Requiere estabilización previa sólida y formación específica. Procesamiento titulado.
Terapia de Esquemas	Trabajo en esquemas nucleares de desconfianza/abuso. Útil si TLP emergente confirmado.

Evaluación obligatoria antes de iniciar fase 2: aplicar escalas disociativas A-DES o MID-C.

■ FASE 3 — INTEGRACIÓN Y RECONEXIÓN

- **Objetivo:** Reconstrucción identitaria y reconexión vital.
- **Intervenciones:** ACT adaptada · Terapia Narrativa para reconstruir la historia vital · Trabajo en vínculos seguros e identidad futura.
- **Cierre:** Planificado con atención a posibles reacciones de abandono y cierre gradual.

■ EVIDENCIA CIENTÍFICA Y CUIDADO DEL EQUIPO

DBT-A	Nivel A — Alta evidencia para autolesiones y regulación emocional en adolescentes.
TF-CBT	Nivel A — Primera línea en trauma sexual infanto-juvenil (Cohen et al.).
EMDR	Nivel A — OMS recomienda para PTSD; adaptación requerida en CPTSD.

Autocuidado del equipo:

- Riesgo de fatiga por compasión y trauma vicario: obligatorio el autocuidado activo.
- Supervisión clínica regular — individual y grupal — con esp. en casos de trauma sexual y riesgo suicida.
- El equipo que cuida a esta paciente también necesita ser cuidado.